

Astma egenbehandlingsplan

Navn: _____

Fast vedlikeholdsbehandling: _____

Anfallsmedisin (ved behov): _____

Grønn – Astma under kontroll

Symptomer

- Ingen eller sjeldne astmaplager på dagtid
- Ingen nattlige oppvåkninger av astma
- Normal aktivitet og trening
- Sjelden behov for anfallsmedisin utover ev. bruk før anstrengelse

Hva gjør du?

- Fortsett faste medisiner, aktivitet og trening som avtalt
- Vurder anfallsmedisin før trening ved behov
- Unngå kjente utløsende faktorer (f.eks. tobakksrøyk, allergener)

Medikamentell behandling: Ta faste medisiner som foreskrevet. Bruk anfallsmedisin ved behov, se felt over.

Gul – Begynnende forverring

Symptomer

- Våkner av astmasymptomer om natten
- Økt behov for anfallsmedisin sammenlignet med vanlig
- Tynge pust, tetthet i brystet eller økt hoste
- Forkjølelse eller annen luftveisinfeksjon

Hva gjør du?

- Øk bruken av anfallsmedisin etter behov (inntil avtalt maksdose)
- Ro ned tempo, men oppretthold lett aktivitet
- Unngå utløsende faktorer

Medikamentell behandling: Øk anfallsmedisin til _____
Ev. øk fast dose inhalasjonssteroid/ICS-formoterol til _____

Rød – Forverring

Symptomer

- Økende pustebesvær
- Dårlig eller kortvarig effekt av anfallsmedisin
- Hoste med gult/grønt oppspytt, ev. feber

Hva gjør du?

- God pusteteknikk, roligere tempo, lett aktivitet
- Start kur med prednisolontabletter som avtalt
- **Kontakt lege for medisinsk vurdering!**

Medikamentell behandling:

1. Fortsett/øk anfallsmedisin ved behov
2. Prednisolon: _____ tabletter i _____ dager
3. Antibiotika (kun ved avtale med lege): _____

Rød – Alvorlig / kritisk forverring

Symptomer

- Svært tungpustet, vanskelig å snakke i hele setninger
- Liten eller ingen effekt av anfallsmedisin innen 5–10 minutter
- Blek eller blålig hud/lepper, du er svært engstelig eller utmattet

Hva gjør du?

- **Ring 113**
- Sitt i ro med god støtte, bruk leppepust
- Ta anfallsmedisin på nytt hvert 5.–10. minutt til du får hjelp
- Ikke vent med å søke akutthjelp